EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 71686
SERVICIO : MEL HOMBRES HSC
FECHA : 2023-10-02 13:59:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: CAROL ESTEFANIA MUNOZ JARPA			RUN	: 19.918.520-9
F.Nac	: 03-09-1998	Edad	: 25 AÑOS	Género	: Femenino
Dirección	: LOS ESPINOS 284			Comuna	: SAN NICOLAS
Previsión	: FONASA A	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2023-10-02	Fecha Egreso	: 2023-10-02 13:59:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I82.8-EMBOLIA Y TROMBOSIS DE OTRAS VENAS ESPECIFICADAS

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Ingreso y Egreso de Medicina

Diagnosticos de Egreso:
-FLegmon Periamigdalino en tratamiento.
-Tromboflebitis Septica Yugular Interna Derecha en tratamiento.

-Sin antecedentes Morbidos.
-Sin Alergia a Medicamentos

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J03.0-AMIGDALITIS ESTREPTOCOCICA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

-Consulta por cuadro de dolor faringeo y fiebre alta
-Diagnosticada de amigdalitis donde se administra penicilina en 2 oportunidades.
-Consulta por fiebre alta y trismus el dia 29.9.2023 con parametros inflamtorios altos y febril. Examen fisicod e ingreso con abombamiento d epaladar blando derecho y desviaicon de uvula hacia lado conrtario. Evaluado por cirugia sin manejo quirurgico. Se ingresda para medicina por Dr Prado.

TAC de ingreso:
-Amigdalitis Aguda Flegmonosa
-Trombosis focal yugular interna derecha (tercio medio pequeño defecto de replecion al contraste)

Laboratorio de ingreso
Lactato 1.2 PCR 175.5 Crea 0.7
GB 13000 / PL 164000 / HB 12.5

Completa 4 dias de ingreso con excvelente ewvolucion clinica.
Afebril .
Sin dificultad para apertura bucal.
Alimentacion normal.
Sin dificultad respiratoria

Ex fisico abombamiento de paladar blanco derecha pero ya sin desviacion de uvula. Por lo tanto buena evolucion. En condiciones de manejo en Hodom.

PLAN DE MANEJO:

Planes:
-Se Deriva a Hodom para continuar con manejo antibiotico hasta completar 14 dias. 5 dias biasociado y posteriormente salida con ceftriaxona.
-Anticoagulacion Oral dcon DOAC por 3 meses.

-----Si mantiene buena evolucion , puede cambiar a amoxicilina oral 1g cada 8 horas a partir del dia 6.10.2023 y suspender ceftriaxona. (completar antibioticos hasta el dia 11.10.2023)

INDICACIONES AL ALTA

1. Indicaciones
2. -Regimen Liviano
3. -Abundante hidratacion oral 2000cc de agua al dia
4. -Ceftriaxona 2g ev al dia -- Ultima dosis 11.10.23
5. -Gentamicina 160mg ev al dia --- Ultima dosis 3.10.23
6. -Dipirona 2 comprimido cada 8 horas por 5 dias
7. -Paracetamol 2 comprimidos cada 8 horas por 5 dias.
8. -Dabigatran 150mg cada 12 horas (por 3 meses)
9. -Control Policlinico de Medicina Interna en 3 semanas para contianuar con anticoagulantes y solicitar angiotac para 2-3 meses mas y eventual suspension de dabigatran.
10. -Control SOS en Urgencias.

EXÁMENES Y RESULTADOS

Control en: 21 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

Jorge Andres Villa Flores
MEDICO TRATANTE
16178692-N

JEFE SERVICIO